

NOME:	ISABEL FERRAZ CANTERAS	IMC:	31
IDADE:	POUSA		
SEXO:	59		
SOLICITANTE:	Feminino		
	Bruna Irigoitia	DATA:	13-11-2024

POLISSONOGRAMA

Aspectos Técnicos:

Estudo polissonográfico noturno domiciliar realizado com equipamento NeuroVirtual® BWMini PSG, seguindo normas e diretrizes recomendadas pela AASM – Academia Americana de Medicina do Sono.

Realizada avaliação simultânea dos parâmetros abaixo:

- Eletroencefalograma: Montagem em F3-M2, C3-M2, O1-M2, F4-M1, C4-M1, O2-M1
- Eletrooculograma
- Eletromiograma: Região submentoniana e m. tibial anterior bilateral
- Ronco
- Fluxo aéreo oral e nasal através de termistor e canula nasal de pressão
- Posição corporal
- Análise pletismográfica de esforço respiratório torácico e abdominal
- Saturação arterial de oxigênio (SpO2), eletrocardiograma (ECG) e frequência cardíaca

Resultados:

Exame iniciado 13/11/2024 22:00 horas e concluído 14/11/2024 06:00 horas.

A latência para início do sono foi de 27,5 minutos e a latência para o sono REM foi de 192,0 minutos.

O tempo total de sono foi de 480,0 minutos, com **eficiência do sono (T T S / T T R)* de 83,6%**.

A distribuição do sono mostrou: **55,7%** de estágio N1, **29,9%** de estágio N2, **0,2%** de estágio N3 e **14,1%** de sono REM. No período total de sono permaneceu 78,5 minutos em vigília.

Ocorreram 377 despertares tendo o índice de **(47,1/hora)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0/hora.

O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 49,2/h.

O índice de apneia/hipopneia foi de 49,2/h sendo 23,0 apneia/hora e 26,2 hipopneia/hora.

O número total de eventos respiratórios foi de 329, sendo 175 hipopneias, 154 apnéias obstrutivas, 0 apneias centrais e 0 apneias mistas e 0 RERAS.

A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a saturação média de 91 % e a mínima de 66%.

(*) T T S ⇨ Tempo Total de Sono T T R ⇨ Tempo Total de Registro

Conclusão:

1. Aumento acentuado do índice de apneias-hipopneias (49,2/h), com pausas respiratórias associadas à hipoxemia (SaO2 mínima de 66%) e/ou microdespertares, com pausas mais frequentes durante o sono REM (índice em REM de 79,6)^h
2. Ronco constante e de leve intensidade
3. Índice de movimentos periódicos de membros inferiores normal
4. Índice de microdespertares aumentado
5. Arquitetura de sono com:
 - a. Eficiência do sono reduzida (83,6%)
 - b. Latência para início do sono normal (27,5)
 - c. Latência de sono REM normal (192,0)
 - d. Porcentagem de N2 normal (29,9)
 - e. Porcentagem de N3 reduzida (0,2)
 - f. Porcentagem de sono REM limitrofe (14,1)


Dr. Heitor Etori

CRM-SP 145.001 RQE 56270-1

Neurologista e Neurofisiologista Clínico – UNIFESP

Título de Especialista em Neurofisiologia Clínica – SBNC

Título de Especialista em Neurologia – ABN